



118. ICI N° 8-4

ARTÍCULO: Principio: “Los pueblos originarios tienen derecho al goce del más alto nivel posible de salud y bienestar en igualdad de condiciones y sin discriminación, considerando los diversos territorios y contextos en los que habita la población indígena. Principio entendido tanto en los marcos epistemológicos propios, considerando su filosofía y forma de vida, donde es central el cuidado de la persona, su entorno y biodiversidad (itrofilmongen), junto a sus prácticas medicinales, espiritualidad e interacción con el modelo de salud público universal”.

ARTÍCULO: Se reconoce y garantiza el ejercicio amplio de los sistemas de medicina tradicional de los pueblos originarios, en el contexto del reconocimiento que establece la OMS, Convenio 169 de la OIT y otros tratados o acuerdos internacionales ratificados por Chile. Considerando su protección, fomento y promoción.

ARTÍCULO: Se otorga el derecho al desarrollo de los modelos de salud indígena, sus concepciones de bienestar, salud-enfermedad, prácticas preventivas y de recuperación de la salud, así como las condiciones que lo garanticen. Solo los integrantes de los pueblos indígenas podrán ejercer las prácticas medicinales ancestrales, correspondientes a su pueblo.

ARTÍCULO: El estado asume la tarea de salvaguardar, proteger y/o recuperar ecosistemas significativos para la medicina indígena, en los distintos territorios donde se encuentra diversidad de especies (itrofilmogen) tales como; animales, herbolaria (priorizando la nativa), semillas, minerales y otros recursos medicinales.

ARTÍCULO: Se garantiza mejores condiciones en todos los planos (estatal, social y cultural), para el ejercicio en las mejores condiciones del rol de los especialistas tradicionales de salud machi, lawentuchefe, zugun machife, pñenelchefe, gütamchefe, en el pueblo mapuche.

ARTÍCULO: Se garantiza el ejercicio en las mejores condiciones para equipos de salud mapuche en contextos de interculturalidad. Se trata por ejemplo de asesores culturales, trabajadores indígenas, keyu machi y coordinadores de equipos de salud mapuche, entre otros, los que son reconocidos por sus territorios, comunidades y asociaciones indígenas. Incluyendo derechos laborales y seguridad social.

ARTÍCULO: Se garantiza la existencia, protección, fortalecimiento y financiamiento de espacios de salud comunitarios donde se desarrolla la medicina ancestral de los pueblos originarios, entre ellos los Centros de Salud Mapuche o lawentuwe Ruka.

Considerando la disponibilidad de espacio público para el funcionamiento de estas instancias de forma independiente a los establecimientos biomédicos, en entornos apropiados y con diseños arquitectónicos pertinentes.

ARTÍCULO: Se asegura un sistema de financiamiento para promover, implementar y desarrollar el derecho a la salud y bienestar de los pueblos indígenas, en sus distintas dimensiones.

ARTÍCULO: Se asegura el derecho a la salud ancestral con enfoque omúnna en el sistema público universal de salud, asegurando su accesibilidad y calidad en lugares apartados.

Sometida a votación el artículo octavo se **rechazó** (9 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

Sometida a votación el resto de la iniciativa, se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).

119. ICI N° 26-4

PROPUESTA: RECONOCIMIENTO DE SISTEMAS DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS SISTEMAS LOCALES DE SALUD AUTOGESTIONADOS.

Se reconoce y protege en su autonomía e integridad, los sistemas de salud tradicionales de los pueblos indígenas, incluyendo sus agentes de salud, procedimientos, sistema de atención, tecnologías, así como sus recursos herboláreos y materiales.

Asimismo, el Estado reconoce, protege y promueve los sistemas y modelos locales de salud autogestionados por organizaciones de pueblos indígenas, consistentes en centros de salud intercultural, hospitales o casas de salud, encargadas de la prevención, promoción, atención y rehabilitación de la salud de su población a cargo por medio de estrategias y modelos propios de los sistemas médicos indígena, biomédico oficial o de acuerdo a sus propias definiciones, de manera autónoma y en relación de cooperación con el sistema nacional de salud, quien salvaguarda su protección, promoción, autonomía e integridad.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).



120. IIC N° 43-4

La salud es un derecho humano fundamental y social, que resulta del equilibrio y la reciprocidad de las personas y comunidades con su entorno ambiental y ecológico, como de las determinantes sociales, políticas, económicas, laborales, culturales, espirituales y educacionales.

El Estado reconoce y respeta los sistemas, prácticas y autoridades tradicionales que imparten salud como machi, lawentuchefe, püñeñelchefe, ngütamchefe y otros agentes de salud de los pueblos y naciones originarias presentes en el país, y garantiza su ejercicio en el sistema público de salud, a través de la medicina preventiva, como complemento a los tratamientos indicados, tanto por los especialistas de medicina occidental como de los pueblos y naciones originarias, así como al tratamiento, promoción, protección y conservación de los tipos de alimentación, considerando también el rescate, valoración y uso de las semillas originarias y/o nativas, las hierbas y plantas medicinales, animales, minerales de interés vital y otros recursos naturales de uso medicinal, en sus tierras y territorios ancestrales, con el fin de permitir el más alto bienestar de salud física, mental, espiritual omunitaria, además de asegurar su preservación e integridad, conforme a su identidad territorial.

Es deber del Estado financiar, promover y fomentar los sistemas de salud propios de los pueblos y naciones originarias y su participación en el sistema público de salud, con determinación de las comunidades, proporcionando la infraestructura y medios adecuados y pertinentes para el efectivo ejercicio de estos derechos. Considerando que el Estado debe garantizar que cada centro de salud, cuente con la totalidad de sus funcionarios y directivos con conocimiento respaldado en cosmovisión y sistemas de salud propios de los pueblos y naciones originarias, según corresponda.

El Estado debe facultar a los agentes de salud de los pueblos y naciones originarias, para respaldar y justificar las ausencias laborales, en la recuperación/restauración de la salud, inherentes a las indicaciones y tratamientos que determinen los distintos agentes.

El Estado debe respetar, garantizar, proporcionar recursos y promover el derecho de los agentes encargados de impartir salud en cada pueblo y nación originaria, para trasladarse libremente por todo el territorio en busca de plantas u otros elementos de carácter medicinal, considerando que las fronteras de los pueblos originarios, son distintas a las impuestas por el Estado.

El Estado garantiza el acceso a un sistema único y público de salud, regido por los principios de universalidad, gratuidad, interculturalidad, complementariedad, solidaridad, participación, información y protección de derechos y del medio ambiente. Y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, se podrá escoger libremente la complementariedad en salud para acceder, sin discriminación, con pertenencia cultural y enfoque de género.

El Estado debe garantizar la conservación, protección y recuperación de los territorios en sus elementos naturales, ya que son fuentes de vida, de salud, y de buen vivir, por tanto, se debe trabajar complementariamente con las diferentes instituciones del estado o privadas, que tengan relación con el territorio, conforme a la utilización de elementos introducidos que dañen el medio ambiente, la salud y el entorno cultural.

El Estado debe tomar medidas para prevenir y/o prohibir que los pueblos y las personas indígenas sean objetos de programas de investigación, experimentación biológica o médica y en caso de su autorización, procurar que la información sea analizada en conjunto, para generar estrategias de prevención atinentes a las realidades de los territorios y comunidades correspondientes.

Frente a cualquier vulneración o amenaza a los derechos garantizados en estos artículos, cualquier individuo o colectivo podrá interponer un recurso de protección ante la corte de apelaciones respectiva, con el fin de que se restablezca su derecho amenazado o vulnerado.

Se creará una Dirección dependiente de la Superintendencia de Salud con participación representativa de los pueblos indígenas, con el fin de supervigilar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de los deberes estatales en relación a la salud intercultural.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención).

121. IIC N° 72-4

Agréguese una letra al catálogo de derechos fundamentales de la nueva Constitución.

Artículo X: Derecho a la salud intercultural. Toda persona perteneciente a los Pueblos y Naciones Indígenas tiene derecho a la prevención, curación, promoción y rehabilitación según las costumbres y prácticas culturales propias. El Estado debe garantizar el acceso y atención sin discriminación arbitraria; velando por la incorporación de pertinencia cultural en los servicios de salud pública; fomentando el acceso de los miembros de pueblos indígenas a espacios territoriales de significación espiritual para fines medicinales y de sanación.



El Estado promueve y reconoce los sistemas de salud autogestionados por las organizaciones de pueblos indígenas como los centros de salud intercultural, hospitales y ruka o casas de salud, son encargadas de la prevención y atención de la salud de la población por medio de modelos propios de los sistemas indígenas, de manera autónoma y en cooperación con el sistemas de salud nacional.

Agréguese los siguientes artículos vinculados a “Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales”.

Artículo “X”: Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y promover sus sistemas de salud ancestral en el marco de su propia comprensión (Kimün ka Rakiduum) y configuración de mundo (Itrofil Mongen). Es deber del Estado fomentar, garantizar y respetar la salud propia ancestral sin intervención, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho.

Artículo “X”: El Estado en consulta y cooperación con los pueblos y naciones indígenas debe garantizar el manejo sostenible, conservación y fomento de los ecosistemas asociados a la proliferación de medicina ancestral y los lugares de sanación espiritual, además propender el libre tránsito de las medicinas de los pueblos indígenas en los diferentes territorios.

Artículo “X”: El Estado mediante sus instituciones administrativas, legislativas o de otra naturaleza, deben reconocer, validar y garantizar el desarrollo de prácticas, procesos y uso de elementos naturales propios de los pueblos indígenas para la sanación, fomentando la elaboración de medicamentos y productos para el cuidado del bienestar personal y su libre comercialización, fundamentadas en las prácticas ancestrales.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención).

122. IIC N° 85-4

ARTICULADO: El Estado Plurinacional de Chile garantiza el derecho a una salud pública de acceso y cobertura universal y gratuito general, preventiva del surgimiento de enfermedades y oportunamente curativa. Descentralizada, democrática con participación vinculante de los pueblos y naciones existentes en el territorio. Pertinente culturalmente y decolonial, capaz de garantizar el bien estar personal, colectivo y del ecosistema, partícipe de la colaboración y solidaridad internacional.

Administración en Salud. Autonomía, Co-Gobiernos e Interculturalidad.

ARTICULADO: El estado debe reconocer, respetar, no transgredir y aportar según solicitud en las realidades locales y/o territoriales, en aquellos procesos y/o sistemas autónomos indígenas en salud, desarrollando una relación de colaboración, para garantizar el bien estar personal, colectivo, comunitario y del ecosistema.

ARTICULADO: El estado debe garantizar la materialización de la plurinacionalidad en las plataformas de poder y decisión, a través de un co-gobierno proporcionalmente representativo en las instituciones y centros de salud que se encuentren inmersos en territorios donde exista población indígena, en todos sus niveles de complejidad (primario, secundario y terciario, así como administrativos regionales, provinciales y comunales). Para esto el estado debe propiciar los recursos y medios necesarios para la formación, capacitación y especialización de los escaños. Los integrantes indígenas serán elegidos y avalados por comunidades, autoridades ancestrales y agrupaciones Mapuche.

ARTICULADO: El estado plurinacional reconoce que la salud de los pueblos indígenas está ligada directamente con los ecosistemas, y que esta vinculación cultural-espiritual equilibrada es el eje promotor de su salud. El estado debe garantizar la protección, el resguardo y recuperación de los ecosistemas y sus derivados los cuales no pueden ser alterados por particulares ni gobiernos.

ARTICULADO: El estado garantizará la descentralización e interculturalidad de salud a través de las postas rurales interculturales, para que sean el eje fundamental de un modelo de primarización de la salud con enfoque familiar-comunitario y de pertinencia cultural. Dotando de un Equipo Permanente Integral de Salud y los respectivos recursos materiales y tecnologías necesarias para un óptimo trabajo de promoción y prevención en salud que cuente con la rotación permanente de especialistas y una vinculación efectiva con CECOSF, CESFAM y Hospitales.

ARTICULADO: Las Postas Rurales Interculturales podrán desarrollar redes de vinculación con la salud Ancestral de los pueblos indígenas, brindando condiciones materiales y recursos para que las personas puedan recibir oportunamente la atención y/o derivación a sistemas o instituciones más autónomas de salud, donde el estado colaborará con lo que autoridades ancestrales y/o comunidades indígenas soliciten.

ARTICULADO: La pertinencia cultural e interculturalidad en salud debe ser garantizada en sus instituciones y procesos, para esto se desarrollará una malla curricular intercultural, con pertinencia cultural en salud, que integre enseñanza media (captación de futuros profesionales y



técnicos en salud), Universitaria, Técnica y de Postgrado (especialidad comunitaria indígena bilingüe) en cada una de las carreras que aportan al sistema de salud. También la creación de centros de formación y práctica, así como el perfeccionamiento de las instituciones y centros de salud como espacios práctico-docentes. Este proceso será implementado en estrecho vínculo con el Sistema educativo para concretizar la base educativa-científica-cultural de un nuevo modelo de salud pública plurinacional.

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).

123. IIC N°95-4

SALUD INTERCULTURAL Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen derecho a la salud en su dimensión individual y colectiva. Los pueblos tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud preexistentes, así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales, incluyendo la dimensión transfronteriza. Asimismo, en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, tienen el derecho de acceder a sistemas de salud sin discriminación, con pertinencia cultural, y desarrollando sus propias instituciones y prácticas de salud.

El Estado a través de todas sus instituciones públicas, debe garantizar el adecuado acceso al uso de la medicina ancestral de los pueblos, en conjunto con la medicina occidental, sin ningún tipo de discriminación ni cuestionamiento por parte de la institucionalidad pública, garantizando siempre el diálogo clínico respetuoso entre ambos sistemas, en beneficio de las personas y sus familias, ya sean pertenecientes a pueblos preexistentes o no.

El Estado debe reconocer la validez de ambos sistemas, respetando el sistema de validación comunitaria en conjunto con el método científico, sin ningún tipo de desmedro. Además, garantizará un financiamiento adecuado para la cobertura de atención de salud, en general y con especialidades, en todo el país

El Estado deberá adoptar medidas eficaces para garantizar plenamente el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de permitir el más alto goce de salud física, mental y comunitaria.

Será deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud de los pueblos indígenas, tanto en su dimensión individual como colectiva, el que será universal y gratuito. Las comunidades indígenas tendrán derecho a designar a facilitadores interculturales y referentes de medicina tradicional en los sistemas de salud pública.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

124. ICI N° 102-4

Se reconoce y protege en su autonomía e integridad, los sistemas de salud tradicionales de los pueblos indígenas, reconociendo la calidad de quienes realizan tratamientos y practica de salud, los procedimientos, sistema de atención, y los insumos en hierbas usados.

El Estado incluirá a través de una Ley la salud de los pueblos originarios en los centros de atención primaria y hospitales y los declarará como plurinacionales e interculturales.

Reconocerá los centros o casa de salud propias de los pueblos originarios y proveerá de recursos para su funcionamiento.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones).

125. ICI N° 128-4

ARTÍCULO X: El Estado reconoce y oficializa la existencia de la medicina ancestral indígena y/o tribal en el territorio chileno propiciando su aplicación en quienes lo necesiten otorgando los implementos necesarios para poder ejercer la medicina respondiendo a los conocimientos, normas, reglas y protocolos de cada nación originarios y/o tribal.

ARTÍCULO X: El Estado promueve e incorpora la medicina ancestral indígena y/o tribal en los principales servicios de salud del país acorde a la demanda de la población indígena y/o tribal de cada territorio habitado.

ARTÍCULO X: El Estado propicia, financia y otorga infraestructura que responda a la sabiduría de cada nación originaria y/o tribal de cada localidad correspondiente para la correcta ejecución de la atención de salud respondiendo a los protocolos, normas, reglas y conocimientos de cada territorio.

ARTÍCULO X: El Estado responde, atiende, consulta y recepciona demandas de la población perteneciente a una nación originaria y/o tribal para la efectiva construcción y creación de espacios de atención medicinal respetando la sabiduría, norma, reglas y protocolos de cada territorio.



ARTICULO X: *El estado capacita a personal de salud alópata en torno a la salud interculturalidad, sabiduría indígena y/o tribal, conocimientos ancestrales, prácticas culturales, diversos tipos de medicinas, diversidad de roles, entre otras cosas, acordes al territorio, para potenciar el trabajo en conjunto sin generar exclusión entre ambos.*

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

126. ICI N°205-4

SALUD *Los pueblos indígenas y naciones originarias, tienen derecho a la salud en su dimensión individual y colectiva.*

Los pueblos y naciones originarias tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales.

Asimismo, en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, tienen el derecho de acceder a sistemas de salud sin discriminación, con pertinencia cultural, y desarrollando sus propias instituciones y prácticas de salud. En los territorios indígenas, la administración de los sistemas de salud estatal será progresivamente traspasada a los pueblos y naciones originarias. Y se debe iniciar con la Coadministración.

Será deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud de los pueblos indígenas, tanto en su dimensión individual como colectiva.

Las personas que entreguen prestación de salud intercultural en los centros de Salud tienen Derecho a Remuneración.

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

127. IIC N° 215-4

23. El derecho al acceso a las prestaciones de salud.

Corresponderá al Estado la regulación de las acciones relacionadas con la salud. A través de la ley se podrán establecer la forma y condiciones en que éstas se realicen, debiéndose fomentar la competencia y transparencia en el sector, ya sean instituciones públicas o privadas. El Estado no podrá establecer en su trato respecto de ellas diferencias arbitrarias.

A través de la ley se podrán establecer cotizaciones obligatorias para el financiamiento de la salud de la población, pudiendo cada cotizante elegir libremente por el sistema de salud al cual adscribirse y destinar sus recursos, sea este estatal o privado. Es deber del Estado garantizar la libertad de elección, debiendo apoyar a todas las personas equitativamente, considerando su necesidad, en la forma establecida por la ley.

También se reconoce la libertad de las personas sobre los tratamientos médicos a los que se deba someter. Sólo la ley podrá establecer límites u obligaciones en estas materias, respetando siempre la dignidad de la persona humana.

La acción de los órganos estatales es complementaria a la responsabilidad personal y a la iniciativa privada, siendo deber del Estado fomentar la colaboración público-privada, con criterios de eficiencia en el uso de recursos, oportunidad de la prestación y resguardo de los recursos públicos.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud del derecho aquí consagrado y la forma en que se financiarán, corresponderá exclusivamente al Legislador.”

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 en contra y 5 abstenciones).

128. ICI N° 221-4

“Art. X. La constitución garantiza a todas las personas el derecho a la salud. Es deber del Estado asegurar la disponibilidad de salud indígena en todo el territorio a través de servicios de salud interculturales e inclusivos.”

Sometida a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones).

129. ICI N° 244-4

Artículo 25

1. *Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.*

Se deben considerar estos ejes para contar un mejoramiento efectivo y real



Equidad, a través de este concepto el Estado y el gobierno de turno, se solicita en todo orden de la salud sea de manera equitativa y en igualdad de condiciones para los pueblos indígenas y chileno.

Participación, es un tema importante para los pueblos indígenas, ya que permite visibilizar las demandas en la salud indígena a la Incidencia a contar con políticas públicas pertinente a la cultura y tradiciones de los pueblos originarios/indígenas.

Interculturalidad, este concepto permite que la diversidad cultural que existe en Chile, sea una convivencia entre pueblos como una riqueza cultural e inclusivo y las formas de salud también sean un complemento para mejorar la salud en Chile. El reconocimiento y la valoración del sistema de salud de los pueblos originarios/indígenas junto al respeto de sus espacios pertinentes

Medicina Indígena, esta forma de sanación en los pueblos indígenas, se encuentra en todo el Wall Mapu, en todo el espacio, territorio, tierra, agua, piedra, es decir en ITROFILMONGEN

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

El valor a la vida de todos los seres de la tierra, también nos da vida como un ser más

La protección integral de cada elemento de la ITROFILMONGEN, se habla de todo el entorno natural es desde el Territorio del Wall Mapu, eso es el sistema de sanación para los pueblos originarios/indígenas, la pertinencia de los espacios donde se practica la sanación corresponde el patrimonio cultural tanto material y espiritual.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

La salud desde la visión de los Pueblos Originarios/Indígenas se refiere al conjunto de elementos que compone el entorno social, cultural, ambiental y otros, y que el desequilibrio de estos elementos es causal de la afectación de la salud, por lo tanto, el Buen Vivir es un concepto dinámico y continuo que requiere ser resguardado en su contexto.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Que los Servicios de Salud tenga una relación de igualdad de condiciones con las Instituciones indígenas reconocidos y validado por los pueblos originarios/indígenas en situaciones de: Convenios PESPI y la administración de los recursos financieros.

*Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 en contra y 5 abstenciones).*

130. IIC N° 251-4

1.- (Semma) DERECHOS A LA SALUD Y BUEN VIVIR

Como pueblo Originario tenemos nuestros propios modelos de salud ancestral para restablecer y devolver el equilibrio al derecho del buen vivir, por tal motivo la constitución a de velar por el reconocimiento de nuestros modelos de salud y a las personas que practican y consolidan insertando en el territorio ancestral la medicina natural e intercultural, la integridad física, psíquica, el derecho a vivir en un medio ambiente sin contaminación para ello el tratamiento que se le dará al cambio radical de los procedimientos mineros como metálicas y no metálicas.

El derecho a la alimentación sana y saludable, el derecho a la protección de la salud y nuestra extensa gama de remedios naturales en la cual desde tiempos precoloniales se usaban y se usan, derecho al reconocimiento de nuestra medicina ancestral, derecho a la protección y recuperación además de la rehabilitación de las personas que llegasen a los centros asistenciales como policlínicos, Clínicas y hospitales, el derecho a una atención rápida y no de largas esperas, el derecho a nutrientes naturales sin químicos y a nuestras semillas totalmente nuestras sin alteraciones.

Debemos tener cuidado especial en el tratamiento de las leyes que han sido obstáculos para que los elementos de medicina ancestral puedan usarse.

Derecho a una vida digna, como también el derecho a una muerte digna.

Derecho a los medicamentos en los programas de salud auge.

Derecho a buen tratamiento de las enfermedades.

*Sometida a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 19 en contra y ninguna abstención).*



131. ICI N° 267-4

“El Estado reconoce el derecho a la Salud Intercultural de la Primeras Naciones.

Es deber del Estado garantizar la protección, acceso, conservación y reparación de los espacios naturales que constituyan la fuente de la medicina de las Primeras Naciones.”.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones).

132. IPC N° 01-4

Cláusula que deberá vincularse con el derecho a la salud.

El Estado reconocerá a todas las personas el derecho universal a la salud sexual y reproductiva, a la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, sin coerción, discriminación ni violencia, a los servicios de atención de salud integrales; al derecho a la información y acceso a métodos anticonceptivos, libremente elegidos, eficaces, y de calidad; el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; al acceso a la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo; a la prevención, el diagnóstico, atención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual; asegurando que estos procesos sean realizados conforme a las cosmovisiones de las personas, sin discriminación y violencia.

“Norma Transitoria: En concordancia con lo anterior, se estipula lo siguiente:

- La interrupción del embarazo no será imputable penalmente, hasta que se realicen los cambios normativos correspondientes.

El que por causa de actos, acciones u omisiones sufra perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de estos derechos, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva del domicilio de la persona afectada, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue convenientes y necesarias para restablecer el derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada.”

Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones).

133. IPC N°29-4

DEL DERECHO A LA SALUD El derecho a la salud es un derecho humano, fundamental y social, que tiene por fin el disfrute del más alto nivel de salud y bienestar de las personas y comunidades. La salud es una construcción social y resultado de las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, educacionales y de las interrelaciones de las personas, comunidades y pueblos, con su entorno ambiental y ecológico.

Es deber prioritario del Estado respetar, promover y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, resguardando las vidas. Por ello, debe considerarse la salud de la población en todas las políticas públicas destinadas a consagrar los demás derechos, debiendo el Estado establecer y mantener un modelo de desarrollo económico y social justo, equitativo, sostenible, sustentable, y en armonía con el ambiente, para posibilitar el buen vivir de las personas, las comunidades y los pueblos.

A tal efecto, el Estado deberá establecer un Sistema de Salud, en los términos que se dispone a continuación:

ARTÍCULO II DEL SISTEMA DE SALUD: El Estado garantizará mediante instituciones, normas jurídicas, políticas sociales y económicas, el buen vivir y a su vez la reducción de riesgos, de daños y de enfermedades para las personas, comunidades, pueblos y ecosistemas, así como el acceso universal e igualitario a las acciones y provisión de servicios de promoción, prevención, protección, cuidados, recuperación y rehabilitación de la salud. También debe garantizar su regulación y fiscalización. Para hacer efectivo este derecho, el Estado deberá establecer un Sistema Único de Salud, Universal, Plurinacional e Integrado. Este será Público, Garantista, Solidario, Intercultural, Descentralizado, Desconcentrado y Participativo, centrado en la estrategia de Atención Primaria de Salud, respetando y promoviendo los principios de la Seguridad Social de Universalidad, Solidaridad, Unidad, Igualdad, Evolución progresiva de derechos, Concordancia de la Seguridad Social con la realidad económica, Participación, Obligatoriedad, Integralidad, Inmediatez y Asignación preferente de recursos. Asimismo, dicho Sistema Único de Salud deberá ser gratuito, con una organización adecuada a la realidad y necesidades de cada territorio y su población y debidamente dotado de recursos, el que garantizará la calidad e integralidad de las funciones esenciales de salud pública, con un modelo de financiamiento sustentado en impuestos generales y específicos, dentro de un Sistema Tributario justo, basado en la solidaridad, equidad y progresividad. El Sistema Único de Salud debe respetar las diferentes concepciones y manifestaciones culturales, las diferentes cosmovisiones propias de un Estado Plurinacional, la diversidad de las personas y comunidades que lo integran, teniendo presente el enfoque de derechos humanos, género e inclusión social. La ley establecerá un consejo nacional de salud que tendrá como objetivo dirigir el sistema único de salud y evaluar el cumplimiento de



sus fines y definir las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, sus funciones y facultades resolutivas, así como su composición, la que deberá contemplar a lo menos al ministro de salud y representantes de entidades públicas, de organizaciones de la sociedad civil, de los pueblos originarios y de entidades universitarias y científicas. Además, deberá contemplar consejos regionales y locales con similar composición. El Sistema Único de Salud, deberá promover un modelo de atención organizado en redes territoriales con pertinencia cultural, que cumpla con las siguientes características: a) Pertinencia regional, comunal y local.

b) Participación deliberativa- y además vinculante, en los casos que establezca la ley- de las personas y comunidades.

c) Atención integral, que considere acciones promocionales, preventivas, asistenciales, de cuidados, acompañamiento, rehabilitación y reinserción, entre otras.

En el Sistema Único de Salud podrán participar personas naturales y jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, cuyo giro único sea la provisión de servicios de salud. Serán reguladas por el Sistema, en su ejercicio clínico y financiero, bajo las mismas medidas que las instituciones públicas que lo integran, mediante contrato o convenio de derecho público y percibirán de él por sus servicios, montos iguales a los definidos para el Sistema Único de Salud.

Está prohibido el destino de recursos públicos para auxilio, pagos o subvenciones a las instituciones privadas con fines lucrativos.

El Estado deberá regular y fiscalizar, con facultades suficientes, la provisión de servicios de Salud por parte de privados que no integran el Sistema Único de Salud. Estas entidades y personas naturales no podrán recibir recursos públicos, económicos ni de otra índole, y serán reguladas por la Autoridad Sanitaria y otras instituciones públicas, para dar garantías de calidad pertinencia y aranceles justos que la ley determine. El Sistema Único de Salud debe procurar y fiscalizar el óptimo desarrollo integral de sus trabajadores y trabajadoras, sus justas y protegidas condiciones de trabajo y su relación armoniosa de respeto y cercanía con las personas y comunidades de cada territorio, para el logro del mejor estado de bienestar de los equipos de salud y de las comunidades en las cuales se desempeñan.

ARTÍCULO III

DE OTRAS FUNCIONES

Al Sistema Único de Salud, además de las funciones en el ámbito de cobertura sanitaria y pecuniaria, conforme dicte la ley, le corresponde las siguientes: I. Controlar y fiscalizar procedimientos, productos y sustancias de interés para la salud y participar en la producción de medicamentos, inmunobiológicos, hemoderivados, otros insumos, equipamientos y tecnologías para la salud;

II. Ejecutar las acciones de vigilancia sanitaria, epidemiológica, de salud laboral y ocupacional;

III. Participar en la formulación de la política y la ejecución de las acciones de control sanitario ambiental y territorial.

IV. Garantizar, en el área de salud, políticas de desarrollo científico y tecnológico;

V. Regular, fiscalizar, inspeccionar y efectuar el control sanitario del aire, de los alimentos, de los suelos y las aguas y de los residuos;

VI. Participar en el control y fiscalización de la producción, transporte, almacenamiento y uso de sustancias, productos y residuos especiales, psicoactivos, tóxicos, radiactivos y peligrosos para la salud de las personas y dañinos para el medio ambiente;

VII. Participar en la protección del medio ambiente;

VIII. Regular y fiscalizar condiciones sanitarias ambientales y condiciones laborales, según las normas nacionales e internacionales que rigen en el Estado de Chile.

IX. Instalar un sistema nacional de información clínico sanitario integrado, interoperable y con datos estructurados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: (Sólo Citas de materias.)

Estas deben establecer condiciones y plazos máximos para la implementación del ejercicio del derecho a la salud en un Sistema Único y Universal de Salud.

1. Normas que regulen el tránsito desde el actual diseño fragmentado del Sector Salud (Fonasa, Isapre, Capredena, Dipreca, Prestadores Privados y de las Mutualidades de Empleadores de Seguridad Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales) hacia un Sistema Único, Universal, Plurinacional e Integrado de Salud (SUS).

2. Normas que regulen el tránsito de un sistema de financiamiento por cotizaciones, de cargo de trabajadores/as, a un financiamiento mediante impuestos generales y específicos. Será condición



para ello, el que exista un sistema tributario justo, donde los impuestos sean equitativos solidarios y progresivos.

Sometida a votación se **rechazó** (14 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención).

134. IPC N° 30-4

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

(Este párrafo se integraría al artículo actual garantizando el derecho a una salud mental digna y gratuita para todos los chilenos y chilenas históricamente.)

"Es deber del Estado garantizar la promoción, protección, prevención y atención de la salud mental de todas las personas durante todo su ciclo vital."

La ley protege la vida del que está por nacer.

La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.

El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.

Sometido a votación separada el inciso tercero de la iniciativa se **rechazó** (2 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el resto del articulado se **rechazó** (8 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención).

135. IPC N° 38-4

"La Salud es un derecho social, comunitario y humano inalienable, incluyendo su dimensión física, mental y espiritual.

Es responsabilidad del Estado garantizar efectivamente el acceso a un Sistema Único y Universal de Salud, de carácter solidario, equitativo, participativo, con enfoque de género, intercultural, descentralizado y articulado desde el territorio municipal. Que se base en la prevención y la promoción de la salud, el respeto a los derechos sexuales, reproductivos y de género; que otorgue trato digno para el buen vivir y la muerte humanizada; que sea parte de la relación con la naturaleza y la biodiversidad.

Los servicios de salud deben articularse en torno a la atención primaria de salud y organizarse mediante el fortalecimiento de la red integrada de servicios de salud públicos y otras redes territoriales de salud popular.

El sistema único, universal y público, debe estar suficientemente financiado con impuestos progresivos de modo que las prestaciones sean gratuitas al momento de su realización, que los actores que las presten sean sin fines de lucro, que asegure el acceso en un plazo razonable y otorgando prestaciones de calidad."

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención).

136. IPC N° 39-4

El Estado de Chile reconoce el derecho de toda la población al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental, espiritual, sexual y reproductiva de acuerdo a su origen cultural, y en un medioambiente saludable. Esto con el fin de que todas y todos puedan gozar del bienestar necesario para ser igualmente libres.

Para tales efectos, es deber del Estado garantizar la ejecución de estrategias y acciones de salud pública, como son la prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de la salud individual; protegiendo las condiciones sociales en que viven las personas y en que acceden a prestaciones asistenciales.

Corresponderá al Estado diseñar e implementar un sistema de salud capaz de garantizar las prestaciones sanitarias, atendiendo las necesidades de las personas independiente de su capacidad de pagar por ellas. Todo ello considerando los principios de equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, calidad, eficiencia y enfoque de género. Todo sistema de salud debe incluir instancias de integración y/o coordinación de toda la red sanitaria, la intersectorialidad y las comunidades.



El Estado procurará que el sistema de salud priorice sus esfuerzos sanitarios en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad con perspectiva intercultural y de género. Para esto se organizará a través de redes integradas, con una atención primaria que, además de ofrecer prestaciones asistenciales, oriente su gestión a la promoción de la salud y la participación comunitaria, con énfasis en los determinantes socioculturales y en los procesos protectores de la salud.

El sistema universal de salud será financiado a través de un fondo único que mancomune las cotizaciones de la población con impuestos generales. Estos se destinarán íntegramente a este sistema, avanzando hacia un modelo de financiamiento basado en impuestos generales de carácter progresivo y bajo los principios de la seguridad social.

Sometida a votación se **aprobó** (16 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones).

137. ICC N°3-5

Artículo XX.

Artículo X. En caso alguno se admitirá la construcción de infraestructuras o el ejercicio de actividades económicas que impliquen la utilización de minerales o elementos reconocidos mortales, como el asbesto, o como dañinos a la salud o perjudiciales cuando alcanzan umbrales considerados críticos. A su vez, el Estado velará por una permanente revisión de los límites permitidos, de acuerdo a estándares científicos, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ajustar la normativa a estándares científicos, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ajustar la normativa, y todos los actos administrativos que sean pertinentes para el desarrollo de construcciones y/p actividades económicas a niveles seguros.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones).

138. ICC N°6-4

Artículo XX. "La Constitución asegura a todas las personas:

Nº A) El derecho a la reproducción humana asistida en la forma y condiciones que determine la ley. El Estado se obliga a asegurar el acceso progresivo a técnicas de reproducción asistida, para todas las personas con imposibilidad de concebir.

El legislador deberá establecer reglas especiales sobre la identidad de las niñas y los niños y su filiación, para los distintos casos de reproducción humana asistida, debiendo siempre velar por su interés superior".

Sometida a votación se **rechazó** (14 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones).

139. ICC N°126-4

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

Número XX: El derecho al acceso a las prestaciones de salud.

Corresponderá al Estado la regulación de las acciones relacionadas con la salud. A través de la ley se podrán establecer la forma y condiciones en que éstas se realicen, debiéndose fomentar la competencia y transparencia en el sector, ya sean instituciones públicas o privadas. El Estado no podrá establecer en su trato respecto de ellas diferencias arbitrarias.

A través de la ley se podrán establecer cotizaciones obligatorias para el financiamiento de la salud de la población, pudiendo cada cotizante elegir libremente por el sistema de salud al cual adscribirse y destinar sus recursos, sea este estatal o privado. Es deber del Estado garantizar la libertad de elección, debiendo apoyar a todas las personas equitativamente, considerando su necesidad, en la forma establecida por la ley.

También se reconoce la libertad de las personas sobre los tratamientos médicos a los que se deba someter. Sólo la ley podrá establecer límites u obligaciones en estas materias, respetando siempre la dignidad de la persona humana.

La acción de los órganos estatales es complementaria a la responsabilidad personal y a la iniciativa privada, siendo deber del Estado fomentar la colaboración público-privada, con criterios de eficiencia en el uso de recursos, oportunidad de la prestación y resguardo de los recursos públicos.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud del derecho aquí consagrado y la forma en que se financiarán, corresponderá exclusivamente al Legislador."

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención).

140. ICC N°307-4

Artículo XX. EL DERECHO A LA SALUD Toda persona tiene derecho a la protección de la salud mental y física. Es deber del Estado garantizar acciones de prevención, promoción, protección y



recuperación de la salud, y de rehabilitación del individuo, que contribuyan a la máxima satisfacción de este derecho, considerando las atenciones especiales necesarias para las personas que lo requieran.

El Estado deberá asegurar, en colaboración con la sociedad civil, que toda persona obtenga el acceso a prestaciones de salud conforme a los principios de equidad, atención oportuna, universalidad, solidaridad, eficacia y libre elección, en la forma establecida en esta Constitución y las leyes.

Los órganos de la administración del Estado fomentarán la educación sanitaria, el deporte, los hábitos de vida saludable y el descanso necesario.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

141. ICC N° 379-4

Artículo XX: Toda persona tiene derecho a la salud. Se entenderá la salud desde un enfoque integral como un estado de completo bienestar biopsicosocial y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades.

Artículo XX: El Estado debe garantizar el derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles, esto abarca la ejecución de acciones y prestaciones de salud contemplando los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, no discriminación e igualdad de acceso a la atención de salud y a los servicios de salud, accesibilidad física y geográfica, accesibilidad económica, acceso a la información, aceptabilidad, pertinencia cultural, pertinencia etaria, y calidad.

Artículo XX: El derecho a la salud está garantizado a todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna, mediante un Sistema Nacional de Salud basado en la Atención Primaria y con financiamiento mediante impuestos generales. El Estado ejerce las funciones de rectoría del sistema, considerando acciones de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y muerte digna.

Artículo XX. Las instituciones privadas podrán participar en el sistema de salud, de conformidad con sus directivas y financiamiento propio. Los actores privados deben organizarse en base a los principios y pleno respeto a los derechos que rigen la presente Constitución; quienes además se encontrarán regulados, supervisados y fiscalizados por el Estado en la forma que la ley señale.

Artículo XX. Salud intercultural. Los pueblos originarios y diversas naciones que habitan nuestro territorio tienen derecho a la salud en los términos que reconoce la Constitución, considerando especialmente su cultura, prácticas, tradiciones y cosmovisión.

La convencional Meneses **retiró** la iniciativa.

142. ICC N° 387-4

ARTÍCULO XX: DERECHO A LA SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL

Todas las personas, pueblos indígenas y naciones originarias, tienen derecho a la salud en su dimensión física y espiritual, individual, colectiva y con pertinencia cultural, incluido el derecho a acceder a los sistemas de salud, tratamientos y medicamentos.

Es deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud como un bien público, de las personas y los pueblos indígenas, considerando todas las determinantes sociales y con el fin de permitir el más alto goce de salud física, mental y comunitaria.

El Estado garantiza un Sistema Plurinacional e Intercultural de Salud, financiado de manera solidaria y de carácter universal y que se regirá por los principios de gratuidad, interculturalidad, solidaridad y justicia social e intergeneracional. Es deber del Estado permitir el uso de la infraestructura pública de salud por parte de las autoridades y agentes de salud de los pueblos y naciones indígenas. Una ley regulará su creación, financiamiento, organización y funciones.

Los pueblos y naciones originarias tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales, incluidas las dinámicas medicinales transfronterizas. Asimismo, tienen el derecho de acceder a sistemas de salud sin discriminación, con pertinencia cultural, y desarrollando sus propias instituciones y prácticas de salud.

Es deber del Estado respetar a las autoridades y personas que imparten salud en los pueblos, garantizando que sus actos y decisiones no sean objeto de ningún tipo de discriminación y tengan los mismos efectos administrativos que los de los profesionales médicos del sistema estatal público.



Los sistemas de formación de médicos y profesionales de salud deben considerar una perspectiva intercultural en sus respectivas mallas curriculares.

En los territorios indígenas, la administración de los sistemas de salud estatal serán progresivamente traspasados a los pueblos y naciones originarias.

ARTÍCULO XX - DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Estado deberá impulsar un proceso de participación y consulta indígena previa, libre y vinculante, a fin de obtener el consentimiento de los pueblos y naciones preexistentes en cuanto al procedimiento mediante el cual se trasladarán la administración de los sistemas de salud estatal a los pueblos y naciones originarias.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

143. ICC N° 396-4

Artículo XX. Derecho a la Salud. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la salud integral, individual y colectiva.

El Estado garantiza este derecho y debe liderar y ejercer la gobernanza de un único Sistema Nacional de Salud, mediante un trabajo intersectorial para la regulación, diseño, ejecución, supervisión, vigilancia, fiscalización y evaluación de las políticas sanitarias. El Estado debe considerar en todas sus decisiones los determinantes sociales de la salud.

El Sistema Nacional de Salud será integrado y deberá asegurar el acceso y cobertura universal de salud. Este se rige por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, inclusión y no discriminación, integralidad, interculturalidad, enfoque de género, pertinencia territorial, eficacia, calidad y progresividad. El Estado promoverá la participación vinculante social y comunitaria en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo, incluyendo la educación en salud.

El Sistema Nacional de Salud se financiará a través de impuestos generales. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores. La administración de los fondos será de exclusiva responsabilidad de una entidad pública regida por los principios de la seguridad social, especialmente la solidaridad y justicia social. Podrán existir seguros privados voluntarios los que en ningún caso podrán duplicar el rol del Estado. Ninguna persona podrá incurrir en un gasto catastrófico en salud.

Las prestaciones de servicios sanitarios deben ser equitativas, efectivas, seguras y de calidad. Estas podrán ser efectuadas por instituciones u organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas. Su acción preferente será la promoción y prevención de la salud, además de las acciones de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, urgencia, inclusión, cuidados paliativos y de fin de vida. La atención primaria constituye la base del sistema nacional de salud.

Es deber del Estado la planificación de la formación, distribución y capacitación permanente del personal sanitario.

El Estado debe implementar un sistema de información en salud que facilite la integración del Sistema Nacional de Salud,

El Estado promoverá y participará de las instancias internacionales orientadas a fortalecer la salud global.

Es deber del Estado, sus órganos y sus autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud de los pueblos y naciones indígenas, con la participación y cooperación de los pueblos interesados.

Artículo XX. Transitorio. En el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigencia de la Constitución, se dictará una ley sobre el único Sistema Nacional de Salud, la cual regulará el liderazgo y gobernanza, el financiamiento, el personal sanitario, las prestaciones de servicios de salud y la participación comunitaria. La misma ley deberá regular el procedimiento de integración al Sistema Nacional de Salud de todas las instituciones y organizaciones sanitarias, incluidas a lo menos las públicas, privadas, las de orden, seguridad y fuerzas armadas, las mutualidades y las organizaciones de beneficencia que ofrezcan prestaciones de servicios de salud.

La ley establecerá un procedimiento para la revisión de los contratos otorgados por el Estado para la construcción de establecimientos sanitarios en todos sus niveles de atención.

Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones).

144. ICC N°492-4

Derecho a la habilitación y rehabilitación en contexto de salud y bienestar



Artículo Único:

Toda persona, a lo largo de su ciclo vital, tiene derecho a la habilitación y rehabilitación para un óptimo funcionamiento, bajo un principio de protección, salud y bienestar, en el caso que presente limitaciones en su funcionamiento producto de alguna condición de salud aguda, subaguda o crónica, y/o discapacidad temporal o permanente que limite su autonomía e independencia para su desempeño diario y participación social.

Es deber del estado, desarrollar las políticas y normas que aseguren, promuevan y garanticen el derecho a la habilitación y rehabilitación. La garantía del derecho a la habilitación y rehabilitación, no exime al Estado de su obligación de generar las políticas y normas para derribar las barreras sociales que impiden el desarrollo de las personas con discapacidad.

Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

145. ICC N° 590-4

XXX.- El Estado promoverá, protegerá y garantizará el derecho a una Salud Mental universal, gratuita, oportuna y de calidad, sin exclusiones ni estigmas, en equidad de condiciones con la salud física, asegurando el pleno respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural, el enfoque de género y la identidad sexo genérica.

XXX.- Es obligación del Estado aumentar gradualmente en sus presupuestos anuales los recursos financieros, humanos y de infraestructura necesarios para garantizar la realización del derecho a la Salud Mental, aumentando progresivamente la capacidad de respuesta del Sector Público a los requerimientos de Salud Mental en los distintos niveles de atención y territorios, respetando los principios de equidad y paridad, y asegurando siempre un nivel mínimo de satisfacción de este derecho.

La Defensoría de los Pueblos tendrá una relatoría especial para estas materias, pudiendo impetrar esta acción en favor de personas afectadas en su salud mental en los casos que determine su ley orgánica.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones).

146. ICC N°658-4

ARTÍCULO ÚNICO:

La medicina alternativa, complementaria e integrativa, es aquella que viene a dar tratamiento apoyando o componiendo la medicina convencional, al ser humano en sus diferentes dimensiones, tanto físico, psicológico y espiritual.

Esta constitución garantiza el acceso digno a la medicina alternativa, complementaria e integrativa a todas las personas, sin discriminación alguna y sin importar su condición social, sistema de salud, origen o cultura.

Es deber del Estado proteger y propender a que este derecho sea entregado a todas las personas, utilizando para ello todos los medios y vías necesarias para tal efecto.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones).

147. ICC N° 668-4

Artículo XX.- Los pueblos y naciones indígenas, como titulares del derecho colectivo a la libre determinación, tienen derecho a mantener y gestionar sus propios sistemas, agentes médicos, instituciones y prácticas de salud indígenas como también al uso y la protección de las plantas medicinales, animales, minerales y otros recursos naturales de uso medicinal, incluyendo los ecosistemas donde estos se reproducen.

Corresponde al Estado, en colaboración con los pueblos y naciones indígenas, salvaguardar los ecosistemas en que los sistemas de salud indígenas se reproducen y, en particular el Sistema de Salud debe garantizar el derecho a la salud y el bienestar de los pueblos y naciones indígenas de manera efectiva y sistemática, con pleno respeto a sus derechos fundamentales, los conocimientos y las prácticas que favorezcan su bienestar, así como la prevención, la sanación y el tratamiento de enfermedades de acuerdo a los marcos filosóficos, a las costumbres y tradiciones de cada pueblo y nación indígena.

Es deber del Estado garantizar un sistema de salud público de calidad, plurinacional, culturalmente pertinente, en igualdad de condiciones y sin discriminación con el resto de la población.

La convencional Mamani **retiró** la iniciativa.



148. ICC N°681-4

Artículo X. Derecho a la salud. La Constitución garantiza a todas las personas el Derecho a la Salud integral.

El Estado deberá considerar en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población.

El Estado garantizará este derecho, a través de un Sistema Universal de Salud de carácter nacional, público e integrado. Este se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, pertinencia territorial, descentralización, eficacia, calidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. El Estado promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo.

El Sistema Universal de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión y cuidados paliativos. La atención primaria constituirá la base de este sistema.

Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.

El Sistema Universal de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.

Los prestadores privados integrados al Sistema Universal de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento.

Artículo Transitorio X. Los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas, las de Orden y Seguridad, junto con los sistemas de salud contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se incorporarán al Sistema Universal en un período de transición que no podrá superar los dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución.

Artículo Transitorio X. Las instituciones privadas que cumplan con los requisitos establecidos en el [art. Derecho a la Salud] y los demás que establezcan las leyes se integrarán al Sistema Universal a través de una ley que regule el traspaso fijando su implementación y gradualidad, cuya dictación no podrá exceder el plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución.

Artículo Transitorio X. El Sistema Universal de Salud comenzará a regir en un plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigencia de esta Constitución. Las cotizaciones obligatorias deberán enterarse al Sistema Universal de Salud en el mismo periodo. La ley fijará los mecanismos y gradualidad de la entrada en vigencia del nuevo sistema y la forma en que las aseguradoras privadas de salud dejen de percibir las referidas cotizaciones. No se podrá reducir el monto de cotización de salud legal vigente por al menos un plazo de 10 años.

Sometida a votación se **aprobó** (18 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones).

149. ICC N°735-4

ARTÍCULO XX : El derecho a la salud integral es un derecho humano.

El Estado reconoce e incorpora a la medicina tradicional, medicina complementaria y prácticas de bienestar de salud dentro del sistema de salud universal. Incluyéndose como parte del Derecho Fundamental a la Salud.

Se contempla el acceso igualitario y transversal de la aplicación de estas medicinas antes mencionadas, en conjunto con la medicina alópata, para que las personas puedan elegir si lo desean, que se integren a sus tratamientos.

Es deber del Estado garantizar la promoción, integración y aplicación en todos los niveles y organismos del sistema de salud de este modelo.

El sistema de salud debe respetar las diferentes concepciones y manifestaciones culturales, las diferentes cosmovisiones internas (de nuestros pueblos originarios) y externas (de otras culturas), de la diversidad de las personas y comunidades que la integran, teniendo presente el enfoque de derechos humanos, género e inclusión social.

El Estado formará un consejo amplio de representantes de todas las entidades necesarias relacionadas con el cambio de modelo, para asegurar su implementación.

El estado generará las condiciones necesarias para el cambio de modelo.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra y 3 abstenciones).



150. ICC N°749-4

El Estado tiene el deber de reparar integralmente la afectación al derecho a la salud por una intervención o tratamiento médico que conlleve efectos adversos o secundarios que menoscaben o lesionen cualquier dimensión de la salud de la persona.

La ley regulará los requisitos de procedencia y la forma en que se realizará esta reparación integral.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 votos en contra y 1 abstención).

151. ICC N°872-4

Artículo XX (...) “Toda persona tiene derecho a la salud mental. El Estado velará por dar protección y asegurar un acceso igualitario y oportuno a prestaciones de medicina preventiva, curativa y de rehabilitación para las personas con trastornos o enfermedades que afecten la salud mental.

El Estado deberá procurar que exista un adecuado balance entre los recursos públicos destinados a tratamientos de salud física y mental, debiendo incorporar progresivamente en los planes de salud aquellos tratamientos de especialidades neuropsiquiátricas y psicológicas. De igual modo, deberá velar porque las prestaciones de salud mental cumplan con los mismos estándares disciplinares, científicos y tecnológicos, que las patologías de carácter físico.

El Estado deberá promover la mejora sistemática de las condiciones de vida y de trabajo de las personas, el deporte y la cultura física, la educación sanitaria y ambiental y los hábitos de vida saludable y establecer políticas de prevención de la tóxico-dependencia”.

Sometido a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 15 votos en contra y 6 abstenciones).

152. ICC N°960-4

Artículo 1. La salud es un derecho humano y social fundamental, de carácter colectivo, plurinacional y orientado al buen vivir, que debe ser garantizado por el Estado, a través de políticas públicas transversales y sectoriales orientadas al bienestar material y subjetivo de sus comunidades, asegurando la equidad y calidad en el acceso de todas las personas a los servicios sanitarios en sus niveles primario, secundario y terciario, velando por la formación de profesionales y técnicos y fiscalización permanente para asegurar una atención digna a los usuarios. Todas las personas que habitan el territorio, sin distinción de etnia o género, tienen derecho a una salud integral y al acceso a la asistencia sanitaria, independiente del tipo y costo de las enfermedades, priorizando por la prevención y promoción de la salud.

Artículo 2. El Estado debe garantizar el derecho a la salud a través de su integración con un sistema de protección social y las políticas estatales relacionadas con el medioambiente, la vivienda y la alimentación, priorizando por la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Del mismo modo debe asegurar el acceso a la asistencia sanitaria, a través de un sistema público, nacional y único de salud, descentralizado, basado en principios de universalidad, calidad, oportunidad, equidad, integralidad, pluralismo, pertinencia epidemiológica y participación. Las entidades privadas sin fines de lucro podrán ser parte complementaria del sistema único de salud. También deberá asumir la rectoría en materia de salud laboral a través de la implementación de políticas específicas en esta materia, asegurando una institucionalidad de seguridad laboral sin fines de lucro que garantice la salud ocupacional de los trabajadores.

Artículo 3 El Estado debe garantizar el financiamiento que asegure el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria en todos sus niveles, considerando un presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de la política sanitaria y la existencia de un seguro único de salud que garantice el acceso universal a la asistencia de todo tipo de enfermedades. A su vez el Estado se hace cargo de coordinar y/o ejecutar directamente la producción y/o distribución de los medicamentos y todo tipo de insumos que se requiera para las tareas de tratamiento y rehabilitación. Los bienes producidos y los servicios otorgados en materia de asistencia no podrán ser privatizados. Las entidades privadas podrán participar de la entrega de servicios asistenciales e insumos sin mediar lucro de por medio.

Artículo 4 La comunidad organizada de la diversidad de pueblos e identidades que habitan el territorio nacional tienen el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones en materia de Salud Pública y asistencia sanitaria a través de mecanismos de cogestión y participación vinculante que permitan el ejercicio de la soberanía en la producción de salud e incidencia en los procesos de tratamiento y rehabilitación, asociado a todo tipo de enfermedades.

Artículo 5. El Estado, a través de su sistema único de salud, debe hacerse cargo de materias de rehabilitación de situaciones o condiciones de discapacidad, tanto de las personas afectadas como de sus cuidadores. El sector privado sin fines de lucro podrá colaborar en esta materia, pero será responsabilidad del Estado ejercer su función de rectoría y financiamiento basal.



Sometido a votación el artículo 3° de la iniciativa se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

Sometido a votación el resto del articulado de la iniciativa se **rechazó** (3 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención).

153. ICC N° 968-4

Artículo XX. Del Derecho a la Salud

La constitución reconoce el derecho a la salud, la cual será entendida como el estado de equilibrio físico, espiritual, mental y social del ser humano con el ambiente y representa un derecho fundamental inalienable al ser humano y a las comunidades. Este derecho integra también el derecho a la salud mental y salud sexual y reproductiva.

El Estado tiene el deber de promover, proteger y garantizar el goce de la salud integral, su cobertura universal y asegurar las condiciones que permitan a todos los habitantes vivir lo más saludablemente posible, para lo cual debe considerar la salud de la población en todas sus acciones y mantener un modelo de desarrollo económico y social justo, equitativo, sostenible, sustentable, y en armonía con el ambiente, posibilitando el buen vivir de las personas y las comunidades. El Estado deberá elaborar políticas especiales para personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados en el acceso y garantía del derecho a la salud, por razones tales como sexo, etnia, nacionalidad, estatus migratorio, identidad de género, orientación sexoafectiva, capacidad, diversidad corporal, entre otras.

El Estado debe garantizar la reducción de riesgos, de daños y de enfermedades para las personas y comunidades, protegiendo los ecosistemas y el medio ambiente e influyendo en el mejoramiento de las determinantes sociales en salud.

Es un deber del Estado garantizar la promoción y prevención en salud, el diagnóstico, los tratamientos, la curación, la rehabilitación y la reinserción de las personas cuyas afectaciones en salud así lo requieran. Los medicamentos son bienes esenciales para el interés general de la nación y la salubridad pública de la población. Su acceso y disponibilidad deberá propender a la universalidad. La ley deberá regular dicho acceso a través de mecanismos de control de precios para garantizarlo. El Estado deberá, a través de los procedimientos que establece la constitución y las leyes, declarar el licenciamiento no voluntario de medicamentos por razones de salubridad pública y el interés general de la nación.

El Estado se organizará en un sistema único, universal y público de salud, el cual tendrá carácter solidario, equitativo, con enfoque de género, plurinacional e intercultural, descentralizado y sustentable con el medio ambiente. El sistema único de salud se estructurará en escalafones de atención de acuerdo a la gravedad y complejidad de las afectaciones sanitarias a tratar. En su base estará la atención primaria de salud, la cual ofrecerá prestaciones asistenciales y orientará su gestión a la prevención y promoción de la salud, además de la participación comunitaria con énfasis en el abordaje de los determinantes socioculturales.

El Estado garantizará la participación organizada y vinculante de la población en las decisiones y gestión del sistema único de salud en todos sus niveles y escalafones.

Una ley establecerá un Consejo Nacional de Salud que tendrá como objetivo dirigir el Sistema Único de Salud, evaluar el cumplimiento de sus fines y definir las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, sus funciones y facultades resolutivas. En su composición deberá contemplarse, al menos, al ministro de salud y representantes de entidades públicas, de organizaciones de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y de entidades universitarias y científicas. Además, deberá contemplar consejos regionales y locales de similar composición.

El Estado propenderá que el sistema único de salud incorpore permanentemente el progreso en la investigación científica y tecnológica en el campo de la medicina, nacional e internacional, según las necesidades del país, promoviendo la producción y adquisición farmacológica, biomédica, y de equipamientos.

El financiamiento del sistema único de salud se realizará con los aportes de todos los agentes económicos y habitantes del país, mediante impuestos generales progresivos. Adicionalmente la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores. Este fondo único será administrado por el Estado, regido por los principios de la seguridad social, especialmente de solidaridad y justicia social.

La ley podrá establecer aranceles por las acciones de salud conforme la capacidad económica de la persona y de sus cargas familiares, pero en ningún caso podrá negarse la atención de salud y ninguna persona deberá incurrir en un gasto catastrófico en salud.

En el sistema único de salud podrán participar personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro y cuyo giro único sea la provisión de servicios de salud mediante contrato o convenio de derecho público. Serán reguladas por el referido sistema en su ejercicio clínico y



financiero, y podrán percibir de él por sus servicios montos iguales a los definidos por el sistema único de salud.

El Estado garantizará la calidad y pertinencia de las prestaciones sanitarias mediante un sistema de acreditación de las instituciones públicas y privadas, las cuales no podrán funcionar sin la autorización respectiva.

Será también deber del Estado, a través de su autoridad sanitaria y otras instituciones públicas, la fiscalización y regulación de la provisión de servicios sanitarios por parte de instituciones privadas que no integren el sistema único de salud, las que en todo caso no podrán percibir recursos públicos de ninguna índole.

Sin perjuicio de la cobertura estatal, se reconoce el derecho de las personas a incorporarse voluntariamente a servicios de salud privados de financiamiento propio.

La convencional Miranda **retiró** la iniciativa.

154. ICC N°977

Artículo XX. La Salud es un Derecho Humano y Social fundamental que debe ser garantizado por el Estado, para todas las personas y comunidades que habitan el territorio nacional, sin exclusión, ni discriminación de ningún tipo.

Artículo XX. El Estado reconoce la salud como el completo estado de bienestar físico, mental, espiritual, social y ambiental del individuo, y no sólo como la ausencia de enfermedad, en consecuencia, debe promover el buen vivir incorporando la diversidad de saberes en los cuidados y apoyos mutuos para garantizar la salud de toda la población.

Artículo XX. Todas las políticas públicas y decisiones relevantes de gestión en cualquier sector evaluarán y considerarán su impacto potencial en la salud de la población que pudiere ser afectada, con el fin de garantizar el Buen Vivir.

Artículo XX. Toda persona cotizará a un fondo único de salud de carácter público.

Artículo XX. Cada persona tendrá derecho a los tratamientos probadamente efectivos basándose exclusivamente en su necesidad. Beneficia a toda la población del país.

Artículo XX. Todas las personas tienen derecho a la atención de salud con enfoque convencional, natural y ancestral, que respete y reconozca la interculturalidad y autodeterminación.

Artículo XX. La participación social vinculante en salud debe ser garantizada como un derecho a crear, formar, decidir y supervisar las políticas públicas, y como una responsabilidad para cada habitante del país, considerando las características propias de las comunidades y los territorios.

Artículo XX. Beneficia a todas las personas que habitan el país, independientemente de su condición.

Artículo XX. El Estado debe garantizar, proteger y promover el derecho a la salud en todas las Políticas Públicas. Los principios rectores de este derecho son: Universalidad, Oportunidad, Integralidad, Gratuidad, Interdependencia, Intergeneracionalidad, Interculturalidad, Intersectorialidad, Transversalidad, Territorialidad y Enfoque de Géneros.

Artículo XX. El sistema de salud pública debe asegurar el acceso universal a todas las acciones que materializan este derecho, tal como la protección, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de las personas y comunidades que habitan el territorio nacional.

Artículo XX. El Estado debe asegurar la descentralización del sistema sanitario según condiciones epidemiológicas de cada territorio a través de procesos de participación social vinculante.

Artículo XX. El Estado debe administrar el sistema de salud en su recaudación. La base de las prestaciones debe ser de administración estatal.

Artículo XX. El Estado debe participar mayoritariamente de la producción y distribución de medicamentos e insumos para la asistencia sanitaria.

Artículo XX. El Estado debe asegurar la creación de organizaciones e instituciones destinadas a la formación, promoción y prestación de las medicinas naturales y ancestrales.

Artículo XX. El Estado debe asegurar la incorporación de la educación sanitaria, preventiva y promocional en todas las mallas curriculares, desde la educación básica, hasta la educación superior.

La convencional Labraña **retiró** la iniciativa.



155. ICC N° 986-4

Artículo XX. La Ley protege el derecho a tener acceso a los cuidados paliativos, proporcionados a través de servicios de salud integrados y centrados en la persona, con equipos multidisciplinarios que presten especial atención a las necesidades y preferencias de cada persona.

Artículo XXX. Se establece que cada Servicio de Salud disponga de una red de atención continuada paliativa: hospitalaria, ambulatoria y domiciliaria.

Artículo XXXX. La ley asegura el acceso a un ambiente seguro donde cada persona pueda recibir los cuidados paliativos en el fin de la vida con pleno respeto de su cultura y creencias en cada región del país, con especial acceso a grupos vulnerables y en riesgo social.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 19 votos en contra y 3 abstenciones).

156. ICC N° 993

Artículo X. La Constitución garantiza el derecho a la salud y bienestar dentro de las escuelas, mediante el acceso a salud escolar integral, tanto de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a instituciones educativas públicas privadas, con o sin Programa de Integración Escolar del país.

Artículo XX. La Ley protege el derecho a la salud dentro de las escuelas, a través de la implementación de unidades de enfermería escolar insertas dentro de los establecimientos Educativos, las cuales cuentan con un profesional de salud capacitado para gestionar la salud de las comunidades educativas, además de propiciar entornos saludables, desarrollo de exámenes preventivos a lo largo del curso de vida de los estudiantes, contar con atención asistencial ante emergencias desarrolladas dentro de la jornada escolar, asistir y propiciar la inclusión de niños y niñas con necesidades especiales de salud y velar por comunidades educativas seguras desde el punto de vista de sanitario.

Artículo XXX. Se establece que cada unidad de enfermería escolar, debe estar articulada y trabajar de forma coordinada, con la red de salud de atención primaria.

Artículo XXXX. Se reconoce la enfermera escolar, como el profesional con especialidad preparado para gestionar la salud de las comunidades educativas.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 votos en contra y 3 abstenciones).

157. ICC N° 1030

Artículo X: La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho a la salud.

El Estado promueve el libre e igualitario acceso a las acciones de salud, sean éstas de promoción, prevención o recuperación de salud, de rehabilitación de la persona o cuidados paliativos en la última etapa de la vida.

El Estado será el ejecutor preferente de las acciones de salud cuando no exista iniciativa privada que permita garantizar su ejecución, en la forma y condiciones que determine la ley.

El Estado coordinará las acciones de salud, sean éstas efectuadas por entidades públicas o privadas.

Asimismo, el Estado efectuará acciones de control y fiscalización al sector de la salud, para el adecuado acceso y ejecución de las acciones sanitarias.

El Estado podrá integrar o coordinar los recursos públicos y privados para la prestación de acciones de salud. Una ley establecerá las bases para efectuar la integración, la que considerará, a lo menos, las condiciones sanitarias que autorizan la aplicación de esta medida, los problemas de salud considerados, la forma de coordinación y el procedimiento de entrega de la correspondiente contraprestación a quienes efectúen las prestaciones.

Existirá un seguro único de salud para todos los habitantes de la República. Cada persona podrá elegir el tipo de administrador de éste y de seguros complementarios voluntarios. Ambos podrán ser públicos o privados.

Con todo, el Estado implementará los mecanismos necesarios para que las personas puedan elegir sus prestadores de salud, sean públicos o privados.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 19 votos en contra y 3 abstenciones).



(c.208) Educación (IIC N° 02, 03, 36, 49, 56, 95, 191, 205, 210, 215, 216, 221, 227, 251, 266, 270; IPC N°01, 03, 11, 14, 15, 23, 50, 62, 70; ICC N° 127, 145, 276, 288, 330, 338, 343, 351, 359, 363, 369, 386, 404, 411, 437, 535, 623, 629, 644, 646, 650, 651, 662, 665, 697, 698, 700, 719, 736, 746, 833, 837, 887, 891, 974, 979, 1019).

158. ICI N°02

ARTÍCULO XX: *“Las primeras naciones, a través de sus instituciones autónomas, tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y proyectar sus sistemas de educación ancestral en el marco de su propia comprensión y configuración de mundo. Es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho”.*

Deberán adoptarse medidas apropiadas para garantizar que las nuevas generaciones sean educadas por las familias e instituciones tradicionales propias del territorio, en el marco de sus saberes, lenguas y conocimientos ancestrales.

Sometido a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 12 votos en contra y 2 abstenciones)

159. ICI N°03

Propuesta frente al Derecho a Educación

Se propone que la Beca Indígena se otorgue automáticamente a los alumnos que tienen dicha calidad cuyo promedio mínimo sea nota 5, sin necesidad de postular a ella ni limitación de cupos, a fin de que el estado asegure los recursos para la educación de los alumnos que aspiren estudios superiores, y que no se vean imposibilitados a ello por falta de recursos económicos.

En cuanto al Derecho a una Educación Intercultural, es necesario que el estado asegure y provea los recursos financieros para la formación y contratación de Educadores Tradicionales que impartan la cultura ancestral y lingüística a los pichikeche.

Sometido a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 25 votos en contra y 5 abstenciones).

160. ICI N°36

ARTÍCULO XX

El Estado reconoce, protege y garantiza el derecho a la educación, como derecho de todo ser humano de adquirir conocimientos que permitan su desarrollo pleno e integral, y para el desenvolver sus capacidades y potenciales.

El Estado reconoce, protege, y garantiza el derecho de todos los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, de mantener y emplear sus instituciones educativas y sistemas educativos propios, a que su lengua y cultura sea considerada en el sistema educativo general, sin perjuicio del derecho a la educación del cual son titulares sus miembros.

Todo niño y niña perteneciente a alguno de los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, tiene el derecho de acceder a todos los niveles y formas de educación que sea posible.

El Sistema Educativo general deberá contemplar y mantener de manera adecuada la educación intercultural plurilingüe, en todos los niveles educacionales, para los miembros de los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, a los cuales también podrán acceder los demás habitantes de del Estado.

El Estado reconoce y garantiza el derecho de los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, de establecer y controlar libremente sus sistemas educativos, en sus propias lenguas, de acuerdo con sus propios métodos educacionales y culturales.”

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra y 2 abstenciones).

161. ICI N°49

1.-DERECHOS DE EDUCACIÓN PROPIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

PROPUESTA DE NORMA

Las personas pertenecientes a los pueblos originarios tienen derecho a acceder a una educación pública, gratuita, de calidad e intercultural, en todos los niveles educativos, y el derecho a acceder a una educación propia, conforme a su propia cultura e instituciones.

Los pueblos originarios tienen el derecho colectivo a establecer, mantener y controlar sus propios sistemas educativos, en sus propias lenguas y de acuerdo a sus propia cultura, instituciones, metodologías de enseñanza y aprendizaje, tanto en espacios rurales como urbanos, conforme al principio de consuetudinariedad que permite mantener, relevar, revitalizar el sistema cultural, estructura social y política, desarrollo territorial, espiritual, de formación y educación.



-El Estado debe velar por el derecho a la educación y el acceso justo a todos los niveles, espacios y formas de educación, garantizando que éste sea respetado como un derecho humano, gratuito, de calidad, integral, intercultural, plurilingüe y plurinacional. Es deber del Estado respetar, promover, garantizar y financiar los sistemas educativos propios de cada Pueblo, respetar las autoridades y personas que la imparten, y promover en el sistema público, la formación de profesionales con conocimientos específicos que profundicen la plurinacionalidad en todos los aspectos de la vida de la sociedad.

El sistema educativo está orientado por la finalidad formar personas integrales y con conocimientos suficientes que puedan ser replicados y transmitidos a otras generaciones pertenecientes a las primeras naciones y a la sociedad en general.

El Estado tiene el deber de garantizar que La ley General de Educación y demás cuerpos normativos del sistema educativo, establezca la obligatoriedad sin condiciones , a incluir en el currículum nacional los conocimientos de los pueblos originarios. Se debe garantizar de manera eficiente y efectiva la participación de los pueblos originarios en la definición del currículum nacional, y la participación de las familias y comunidades en la definición de los Proyecto Educativo Institucional de las unidades educativas a nivel territorial y local y, en general, en el sistema educativo en sus distintos niveles.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 25 votos en contra y 1 abstención).

162. ICI N°56

Artículo XX: Los idiomas de los pueblos-naciones indígenas se consideran idiomas oficiales junto con el castellano.

Especialmente en los territorios autónomos indígenas se usará para documentos y comunicaciones oficiales uno o más idiomas propios además del castellano.

Artículo XX: La educación es un derecho gratuito y universal. La educación estará enfocada en la historia y tradiciones culturales de los pueblos y/o comunidades en el país.

Sometido a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 18 votos en contra y 3 abstenciones).

163. ICI N°95

EDUCACIÓN Y PUEBLOS Y NACIONES PREEXISTENTES Los pueblos preexistentes tienen derecho a una educación gratuita intracultural, intercultural y plurilingüe en todos los niveles del sistema educativo nacional.

El Estado debe garantizar, promover, respetar y difundir el derecho a la educación intercultural, contextualizada y pertinente a los territorios. El Estado debe garantizar y promover que los pueblos preexistentes desarrollen sus propias instituciones educativas, con una participación vinculante de los pueblos en la toma de decisiones. Asimismo, el Estado debe velar por la transversalidad de los saberes, conocimientos culturales y lingüísticos en el curriculum educativo.

El Estado debe respetar y garantizar el desarrollo del enfoque metodológico de la educación intercultural, con participación de la comunidad, permitiendo entender la realidad social, política, económica y cultural de los pueblos, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo de un buen vivir.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra y 2 abstenciones).

164. ICI N°191

Se garantizará el derecho a una educación centrada en el desarrollo de las personas y las comunidades, en armonía con el entorno natural y social.

El Estado tendrá el deber de garantizar la provisión y el acceso justo a todos los niveles y formas de educación, cautelando que el derecho humano a la educación sea gratuito, de calidad, integral, emancipador, intercultural, plurilingüe, laico y no sexista.

El Estado tendrá el deber de resguardar que los pueblos y naciones indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general. Asimismo, el Estado financiará los sistemas educativos propios de las comunidades, pueblos y naciones preexistentes.

Los pueblos y naciones preexistentes tendrán derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

El adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.



Será deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la educación de los pueblos indígenas, en todas sus dimensiones y niveles.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 votos en contra y 2 abstenciones).

165. ICI N°205

EDUCACIÓN:

El estado tendrá el Deber de garantizar el Derecho a la educación, publica, gratuita y de calidad con pertinencia cultural y territorial., Además El Estado debe resguardar que los pueblos y naciones preexistentes, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general El estado debe garantizar el acceso a la Beca Indígena a todos y todas los y las descendientes de pueblos originarios de manera universal.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra y 1 abstención).

166. ICI N°210

Artículo XX El estado de Chile reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza , diferenciándolos por el territorio a cual estos tienen pertinencia.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 14 votos en contra y 1 abstención)

167. ICI N°215

24. El derecho a la educación. La educación es obligatoria desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta el último año de enseñanza media. Los padres o quienes tengan el cuidado legal de niños y adolescentes tienen el derecho preferente para elegir el tipo de establecimiento en que sus hijos o pupilos recibirán enseñanza, así como el derecho de escoger, dirigir y orientar la educación moral y religiosa de sus hijos según sus convicciones, y que sus hijos reciban una educación acorde a la misma.

Para asegurar lo anterior, el Estado tiene el deber de:

i. Financiar la provisión gratuita de estos niveles, así como también, promover y velar por el acceso a la educación superior, tanto universitaria como técnico profesional.

ii. Garantizar la libertad de enseñanza, promoviendo el derecho de las personas e instituciones de crear, gestionar y solventar proyectos educativos autónomos que cumplan con las exigencias mínimas establecidas por la ley, sin establecer diferencias arbitrarias basadas, entre otras circunstancias, en la calidad confesional de los establecimientos. Será deber del Estado reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos, reconociendo también su autonomía. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites que los impuestos por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación.

iii. Promover la libertad de elección de las familias respecto el tipo de educación para los niños y adolescentes a su cuidado, debiendo contribuir equitativamente a su financiamiento en proporción a las necesidades de cada cual, conforme a lo establecido por la ley. El Estado no podrá discriminar entre niños y adolescentes que se encuentren en la misma situación socioeconómica, independientemente del establecimiento educacional al cual asistan.

iv. Fomentar el desarrollo y la calidad de la educación en todos sus niveles y la formación ciudadana y cívica; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación, sea que dichas actividades se desarrollen a través de instituciones públicas o privadas.

Una ley aprobada por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza, tanto a los establecimientos públicos como privados, y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Los proyectos educativos, públicos y privados, no deben estar orientados ni podrán propagar tendencias político-partidistas. El cuerpo docente deberá respetar esta condición, sin perjuicio del reconocimiento de su derecho a la libertad de cátedra.”.

Sometido a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 19 votos en contra y 2 abstenciones).



168. ICI N°216

Artículo XX. El Estado, tiene el deber de contribuir al rescate, revitalización y uso de los idiomas ancestrales como manifestación de las identidades culturales y como elemento fundamental de la continuidad histórica de los Pueblos Indígenas.

El Estado y todos sus órganos deben generar acciones afirmativas con el propósito de contribuir a fomentar el conocimiento y formación en las lenguas originarias, que para los pueblos indígenas constituye un medio para expresar y transmitir sus patrones culturales y relaciones sociales, su propia identidad colectiva, la forma como perciben la naturaleza y el universo que los rodea.

Se propiciará, por parte de los órganos de la administración pública, la incorporación de los idiomas ancestrales en el espacio público, actividades oficiales y documentos de carácter oficial, particularmente, en los territorios indígenas siempre con la participación de los pueblos y naciones indígenas presentes en dichos territorios.

El organismo encargado del sistema público de educación deberá incorporar de manera pertinente los diversos idiomas ancestrales en el currículum escolar nacional, en todos sus niveles formativos. Los establecimientos que estén insertos en aquellas áreas que formen parte de los territorios indígenas o bien que la comunidad escolar indígena, así lo solicite, se deberá incorporar al plan educativo institucional de la unidad educativa respectiva, contenidos con pertinencia indígena y en los idiomas de los pueblos indígenas al que pertenece dicha comunidad educativa.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 20 votos en contra y 3 abstenciones).

169. ICI N°221

“Art. X. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la educación, en todos sus niveles y formas, la que será gratuita, de calidad, intercultural y bilingüe.

Es deber del estado plurinacional tomar las medidas adecuadas para la resguardar el kimün (conocimiento ancestral) y fomentará, en todos los niveles, métodos de aprendizajes pertinentes culturalmente en cada territorio, basados en el inarrumeny el kimkatun como prácticas que permiten aprender de la vida, la naturaleza y sus leyes.

El Estado valora promueve y protege el rol de las educadoras tradicionales mapuche en el traspaso y reproducción de la cultura, la lengua y la costumbre”.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra y 3 abstenciones).

170. ICI N°227

“Artículo X: Educación plurilingüe, intracultural e intercultural. El Estado desarrollará una educación plurilingüe, intracultural e intercultural conforme los distintos conocimientos y cosmovisiones existentes en el territorio.

Los pueblos originarios tienen derecho a impartir su propia educación según su historia, tradiciones, cultura y cosmovisión. El Estado promoverá una identidad plurinacional en el país.”

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 votos en contra y 2 abstenciones).

171. ICI N°266

“Las Primeras Naciones tienen derecho a una educación de acuerdo a sus necesidades y particularidades.

Es deber del Estado garantizar una reforma educacional en todos sus niveles, la que debe contemplar los conocimientos de la Primeras Naciones y sus particularidades.

Dicha reforma será de carácter colaborativo, garantizando el debido proceso de Participación y Consulta Indígena.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra y 3 abstenciones).

172. ICI N°251

2.- (Ppoya) DERECHO A LA EDUCACIÓN, INTERCULTURAL Y BILINGÜE

El pueblo Lickanantay Atacameño promueve y perpetua la cultura ancestral con modelo educativo, es fundamental preservar la pedagogía originaria, aquella que asegura la práctica de la memoria comunitaria, el relato oral y el aprendizaje a través de las experiencias.

Que la educación no sea un martirio sino sea atractiva, significativa, de felicidad y no de estrés.

Reconocimiento en las Aulas a los Educadores tradicionales en la cual reciba un buen trato y buena fe y mejor remuneración por la educación que imparte, un lugar específico para impartir nuestra educación, financiamientos para las salidas a terreno para entregar nuestro conocimiento.



La nueva constitución deberá procurar incorporar la lengua y la cultura de los pueblos originarios del territorio, esto por considerar al estado como plurinacional e intercultural, por tanto, la educación ha de tener ejes transversales que posibiliten el rescate, la conservación y difusión de la cultura e identidad de los pueblos originarios.

Derecho fundamental de una educación gratuita y de calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes en la comunidad educativa.

Sometido a votación el inciso segundo se **rechazó** (6 votos a favor, 23 votos en contra y 4 abstenciones).

Sometido a votación el inciso penúltimo se **rechazó** (7 votos a favor, 22 votos en contra y 3 abstenciones).

Sometido a votación el resto de los incisos se **rechazó** (8 votos a favor, 21 votos en contra y 4 abstenciones).

173. ICI N° 270

El Estado reconoce los derechos lingüísticos de las Primeras Naciones. Es deber del Estado garantizar la protección, conservación y revitalización de la variante lingüística huilliche Tse Süngun.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 22 votos en contra y 5 abstenciones).

174. IPC N°01

Cláusula que deberá vincularse con el derecho a la educación

El Estado reconoce el derecho de todas las personas, desde la primera infancia, a recibir una educación sexual integral, de acuerdo a la edad, y basada en la evidencia; entendiéndola como aquellos conocimientos basados en datos empíricos, aquellas habilidades, actitudes y valores que les permitirán disfrutar plenamente y con dignidad el relacionarse entre pares; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; prevenir situaciones de riesgo y abuso sexual, desarrollando con información sus proyectos de vidas, y el derecho a la información sexual y reproductiva.

El Estado deberá garantizar el acceso de la educación sexual integral en igualdad de condiciones y sin discriminación, en todo el sistema educacional.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra y 3 abstenciones).

175. IPC N°03

Artículo XX.

1. El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el bien integral de la persona humana en las distintas etapas de su vida, tanto en su dimensión corporal como espiritual. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Corresponderá al Estado fomentar y financiar dicho desarrollo desde las comunidades de familias, así como otorgar especial protección al ejercicio de estos derechos.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar, criar y formar a sus hijos, así como el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para ellos. El rol de los órganos del Estado en materia educacional es siempre de ayuda y apoyo, y nunca de sustitución de los padres, salvo que estos o los tutores del menor no puedan ejercer su rol.

2. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Los establecimientos educacionales podrán fundarse para enseñar según un ideario propio, definido libremente por el establecimiento mismo. El Estado no puede imponer una visión única sobre la persona humana, la sociedad y el mundo, ni una única comprensión sobre los derechos humanos. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público. Todo establecimiento educacional podrá oponerse, en razón de su ideario, a impartir contenidos que lo contradigan.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia. Además, financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.



Es deber del Estado asegurar la calidad de los establecimientos educacionales, así como respetar y velar por su autonomía, sobre todo respecto de sus idearios.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Corresponderá al legislador establecer los mecanismos para que el Estado entregue apoyo económico a los establecimientos educacionales que lo requieran sin discriminación entre ellos, mientras cumplan con los requisitos establecidos en este artículo.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Sometido a votación el número 2 se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el resto del articulado se **rechazó** (6 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones).

La convencional Cantuarias votó a favor.

176. IPC N°11

La Constitución asegura a todas las personas:

1. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación, la que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.

2. Los padres, o quienes tengan el cuidado personal en conformidad a la ley, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, o pupilos en su caso.

3. La educación de segundo nivel de transición, así como la educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.

4. El Estado debe respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades, las que deberán cumplir las normas mínimas que el Estado prescriba en materia de enseñanza, así como que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

5. Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

6. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

7. Las Instituciones de educación superior reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país.

8. El Estado asegura asimismo la libertad de cátedra de quienes ejercen la enseñanza.

9. Las personas naturales y jurídicas tienen el derecho de crear, mantener y desarrollar centros educacionales, dentro de los límites del respeto a los demás derechos fundamentales, así como a los deberes y principios constitucionales

10. El Estado, en respeto de la igualdad ante la ley, tiene el deber de garantizar y promover estos derechos, mediante un financiamiento no discriminatorio de la libre elección entre la educación estatal y privada.

11. Las disposiciones de este artículo no se interpretarán como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el primer inciso, y que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado en una ley orgánica constitucional.

12. La determinación de todo lo relativo a las prestaciones exigibles en virtud de este derecho, así como la forma de financiamiento en el marco de lo establecido, corresponderá exclusivamente a la ley.

Sometido a votación el numeral 2 se **rechazó** (12 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el numeral 4 se **rechazó** (9 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).